Algoritmo CIF — Lumbar

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Lumbar. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 1 si «SÍ»

1b ¿El dolor CENTRALIZA con movimientos repetidos (Método McKenzie/MDT)?

- SÍ → 3 Dolor Radicular Lumbar
- NO → 3 Dolor Radicular Lumbar

1c ¿Hay déficit de fuerza, sensibilidad o reflejos en la pierna (comparado con el lado sano)?

- SÍ → 5 Radiculopatía Lumbar (Déficit Neurológico)
- NO → sin hipótesis

SÍ

1 ¿El dolor baja por la pierna (unilateral) y es peor que el dolor de espalda?

NO

2 ¿El paciente es mayor y el dolor mejora al sentarse o inclinarse hacia adelante?

todas

3 ¿Cómo es el patrón de dolor lumbar predominante?

todas

4 ¿Qué patrón encaja mejor? (Revisar siempre cadera y factores contribuyentes.)

Respuestas

SÍ
SLR positivo <60° o Test de Slump positivo → → desvío 1b

NO
Sin irradiación predominante a la pierna → sin hipótesis

Respuestas

SÍ
Dolor bilateral en glúteos/muslos, alivio con "signo del carrito de compras" → 4 Estenosis Espinal / Claudicación Neurogénica

NO
Sin este patrón → sin hipótesis

VASCULAR
Los síntomas al caminar ceden con solo pararse de pie, sin sentarse ni flexionar: sospecha de claudicación vascular → derivación médica → **Derivación médica**
Sospecha de claudicación vascular (los síntomas al caminar ceden con solo pararse de pie): derivación médica para valorar la circulación de las piernas.

Respuestas

Agudo/Rigidez
Síntomas <16 días, sin dolor bajo la rodilla y restricción segmentaria hipomóvil → 1 Disfunción Segmentaria Lumbosacra (Déficit de Movilidad)

Persistente/Inestabilidad
Dolor en rangos finales o posturas sostenidas con sensación de "fallo" → 2 Inestabilidad Espinal Lumbar (Déficit de Coordinación)

Ninguno de los dos
Continuar con el patrón de dolor inespecífico → sin hipótesis

Respuestas

DISCOGÉNICO
Dolor en línea media + preferencia direccional o centralización con movimientos repetidos; puede cambiar de lado → 6 Dolor Lumbar Discogénico

FACETARIO
Paramedial unilateral, dolor en extensión o extensión + rotación, sin pasar de la rodilla; los repetidos no alivian → 7 Dolor Lumbar Facetario

SACROILÍACA
Dolor en zona de Fortin sin dolor en Tuber, no centraliza → 8 Dolor de la Articulación Sacroilíaca

MIOFASCIAL
Banda tensa palpable + punto hipersensible + el paciente reconoce el dolor provocado → 9 Síndrome de Dolor Miofascial Lumbar

NINGUNO
Sin patrón predominante → sin hipótesis

Leyenda

- Pregunta del árbol
- Hipótesis que activa la respuesta
- Derivación médica (el recorrido sigue)
- Sin hipótesis

Al terminar sin ninguna hipótesis activa
La app propone trabajar con «dolor lumbar inespecífico», revisar los factores psicosociales (fase 1 y SINSS) y reconsiderar las respuestas. Si el cuadro es crónico y el riesgo psicosocial es alto, sugiere considerar también sensibilización central.

Fase 4b · confirmar
Cada hipótesis activa se confirma o descarta con sus tests: ver el esquema de confirmación de lumbar.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0